

## Causas Raras de Abdome Agudo Inflamatório

Vamos conversar sobre aqueles diagnósticos diferenciais de abdome agudo inflamatório que não aparecem tanto nas provas, mas quando aparecem, são decisivos para você garantir sua vaga na residência. São causas raras, mas fundamentais de conhecer, porque são exatamente esses diferenciais que separam quem estudou a fundo de quem só passou pela superfície.

Imagina a seguinte situação clínica: você está de plantão e chega um paciente chamado Igor, por volta das 10h30 da manhã. Ele relata que ontem à tarde começou com uma dor em fossa ilíaca direita, teve náuseas, tomou Plasil mas não melhorou. A dor foi progredindo até que ele vomitou. Mesmo após o vômito, a dor persistiu. Ele tomou dipirona, conseguiu dormir, mas às 5 horas da manhã acordou com a região inferior do abdome extremamente dolorosa, sem conseguir nem se movimentar direito. Esse tipo de apresentação já nos faz pensar em apendicite aguda, certo? Mas será que é sempre isso?

Agora vamos mergulhar nos diagnósticos diferenciais dessas causas raras de abdome agudo inflamatório.

Primeiro, temos a **apendagite epiploica**. Essa é uma condição que pode facilmente confundir você se o paciente apresentar sintomas do lado direito do abdômen. Mas o que diabos é um apêndice epiploico? São aquelas pequenas bolsinhas de gordura que ficam penduradas ao longo do cólon, tipo uns penduricalhos de tecido adiposo. A apendagite epiploica acontece quando há uma **trombose da veia central** desse apêndice epiploico, geralmente por torção espontânea da estrutura sobre seu próprio eixo.

Essa condição é mais comum em adultos de meia-idade e pode ocorrer tanto no **cólon sigmoide** quanto no **cólon ascendente**. Quando acontece no cólon

ascendente, especialmente próximo à região da fossa ilíaca direita, você pode facilmente confundir com apendicite aguda. Mas aqui vai o pulo do gato para você não cair na pegadinha da prova: o quadro clínico tem diferenças importantes.

Na apendagite epiploica, o paciente geralmente apresenta uma **dor súbita e localizada**, que não tem aquele caráter progressivo típico da apendicite. Não é aquela dor que começa periumbilical e vai migrando e piorando ao longo das horas. É uma dor que começa de repente naquele local e fica ali, contínua, sem progredir muito. Outro ponto crítico: muitas vezes o paciente **não tem febre** ou apresenta febre baixa, e a **leucocitose não é tão expressiva** quanto você veria numa apendicite aguda. No exame físico, você pode até palpar uma **massa paracólica** na região.

A tomografia de abdome é o exame que fecha o diagnóstico, mostrando um borramento de gordura naquela região específica onde está acontecendo a inflamação do apêndice epiploico. O interessante é que você vê o apêndice cecal completamente normal, sem outras alterações significativas. E qual o tratamento? Totalmente conservador: **anti-inflamatório não esteroide mais analgésico por cerca de 7 dias**. Não precisa de cirurgia, não precisa de antibiótico se não houver sinais sistêmicos de infecção.

Agora vamos falar do **divertículo de Meckel**, que é provavelmente o diagnóstico diferencial mais importante dessa aula e o que mais pode aparecer na sua prova. O divertículo de Meckel representa a **malformação congênita mais comum do trato gastrointestinal**, está presente em cerca de 2% da população. Existe até uma regra dos 2 para você lembrar: 2% da população, 2 tipos de mucosa ectópica possíveis (gástrica e pancreática), localização a aproximadamente 2 pés (cerca de 60 cm) da válvula ileocecal, e sintomas geralmente até os 2 anos de idade.

Classicamente, o divertículo de Meckel é mais sintomático em pacientes do **sexo masculino antes dos 2 anos de idade**, mas atenção: você pode encontrar casos em adultos também. Inclusive, na prática clínica isso acontece. O divertículo se localiza no **íleo terminal**, geralmente a uma distância de 50 a 60 centímetros da válvula ileocecal, e fica na **borda antimesentérica** do intestino.

Qual a complicação mais comum e importante do divertículo de Meckel? **Sangramento nas fezes**, especialmente em crianças. Pensa comigo: você tem uma criança com sangramento digestivo baixo, faz endoscopia digestiva alta e não acha nada, faz colonoscopia e também não vê fonte de sangramento. Aí você já tem que pensar em divertículo de Meckel. A tomografia às vezes consegue identificar, às vezes não. Existe um exame específico chamado **cintilografia com tecnécio-99m pertecnetato**, que marca mucosa gástrica ectópica e pode identificar o divertículo, mas na prática muitas vezes o diagnóstico é feito no intraoperatório, durante uma cirurgia exploratória.

Além do sangramento, o paciente pode apresentar **obstrução intestinal**. O divertículo pode servir como ponto de fixação para volvo ou intussuscepção. E aqui vem um ponto crucial: quando o paciente tem **inflamação do divertículo de Meckel** (chamamos de diverticulite de Meckel), ele pode perfeitamente mimetizar um quadro de apendicite aguda. A apresentação clínica é praticamente idêntica: dor em fossa ilíaca direita, náuseas, vômitos, febre, leucocitose. Por isso você precisa ter esse diagnóstico diferencial sempre na cabeça.

A conduta é a seguinte: se você encontra o divertículo de Meckel e ele está assintomático, em um adulto durante uma cirurgia por outro motivo, a conduta varia. Mas se o paciente é sintomático, se desenvolveu diverticulite, sangramento ou obstrução, você **precisa ressecar** esse divertículo. A ressecção pode ser simples (diverticulectomia) ou pode requerer ressecção segmentar do íleo, dependendo da base do divertículo e se há comprometimento da parede intestinal.

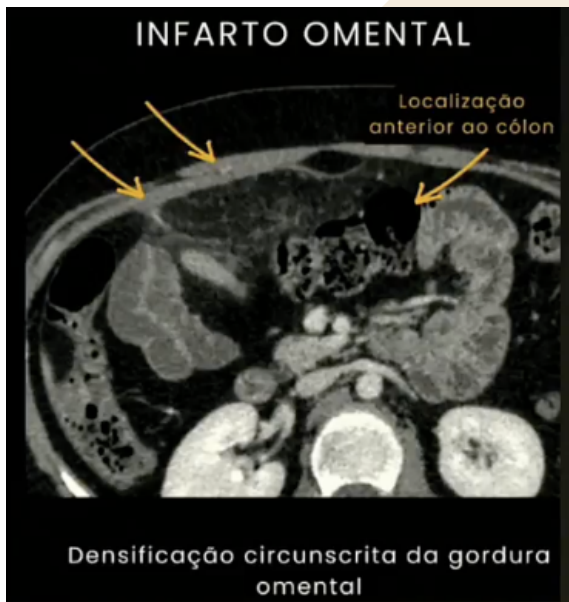
Vamos agora para o **infarto omental**. Esse é bem interessante e mais raro ainda. Estamos falando literalmente de uma necrose isquêmica do omento maior, aquele avental gorduroso que cobre os órgãos abdominais e pode se estender até a região do hipogástrio. O que acontece? Pode haver uma **torção espontânea** do omento ou um **comprometimento vascular** primário. Às vezes o paciente tem uma trombofilia de base que predispõe a essa necrose isquêmica.

Quando há torção ou comprometimento vascular, desenvolve-se trombose local e um processo inflamatório, mas sem origem visceral. Esse é o ponto chave: o

paciente tem um processo inflamatório localizado, mas quando você olha o exame de imagem, **não vê alteração intestinal nenhuma**. O intestino está perfeito, o problema está no omento.

Quando costuma acontecer esse infarto omental? Pode ser secundário a **hérnias abdominais**. O paciente tem uma hérnia, o omento entra no saco herniário e pode sofrer compressão e isquemia. Isso é especialmente comum em hérnias recidivadas, que já foram operadas e voltaram. Outras causas incluem **aderências** (bridas pós-operatórias) e **traumas abdominais** - aquele clássico trauma de guidão de bicicleta ou trauma de cinto de segurança em acidente automobilístico.

O exame de escolha é a **tomografia de abdome**, que vai mostrar uma lesão focal de gordura hiperatenuante, mal definida, localizada entre o cólon e a parede abdominal. Na imagem você vê aquela alteração de gordura que não se parece com alça intestinal, apresenta hipoperfusão e já tem limites relativamente definidos. Quando acontece a isquemia, o omento fica edemaciado, inchado, e você vê esse aspecto característico na tomografia.



O tratamento é **conservador na maioria dos casos**: anti-inflamatórios para controlar a dor e o processo inflamatório local. Se o paciente desenvolver quadro infeccioso sistêmico associado, com febre alta e leucocitose importante, aí sim você adiciona **antibioticoterapia**. Raramente é necessária cirurgia, a não ser que haja complicações como perfuração ou peritonite franca.

Por último, mas não menos importante, temos a **adenite mesentérica**. Essa é uma causa rara, mas que você precisa conhecer porque pode aparecer na prova como pegadinha. A adenite mesentérica é uma **inflamação dos linfonodos do mesentério**, geralmente associada a um quadro de infecção viral ou bacteriana do trato gastrointestinal. Pensa em vírus como Yersinia enterocolitica, adenovírus ou outros patógenos que causam gastroenterite.

É mais comum em **crianças e adultos jovens**, e pode perfeitamente simular apendicite aguda quando os linfonodos inflamados ficam do lado direito do abdome. Mas existem algumas diferenças clínicas sutis que te ajudam a diferenciar. O paciente geralmente tem uma **dor abdominal mais difusa** ou localizada em fossa ilíaca direita, mas sem aquela característica migratória clássica da apendicite. A febre costuma ser **baixa**, as náuseas são comuns, mas a **leucocitose é discreta**, nada daqueles leucócitos super elevados que você vê numa apendicite complicada.

Outro ponto importante: o paciente geralmente **não tem dor migratória**. Na apendicite clássica você tem aquela história de dor periumbilical que migra para fossa ilíaca direita em 12-24 horas. Na adenite mesentérica, é mais um incômodo constante, uma dor que fica ali sem grandes mudanças de localização.

O diagnóstico é feito por **tomografia de abdome com contraste**, que vai mostrar múltiplos linfonodos aumentados no mesentério, principalmente na topografia ileocecal, mas o pulo do gato é: **sem espessamento do apêndice e sem espessamento da parede do ceco**. O apêndice está normal, o ceco está normal, o problema são os linfonodos inflamados ao redor. O tratamento é basicamente **sintomático** com analgésicos e antitérmicos, e você pode adicionar antibiótico se o paciente estiver com sinais sistêmicos de infecção bacteriana, como febre persistente e leucocitose importante.